

41 kandidat yang butuh mata Anda

Dari 118 kandidat pengayaan, 84 sudah keyakinan-tinggi + bersitasi + murni menambah (aman di-skim borongan). Yang tersaji di sini cuma yang **benar-benar perlu keputusan Anda**: 21 koreksi-clue (M11) + 13 keyakinan-sedang (M11) + 7 temuan cross-check PPK Kemenkes resmi (2026-07-10). Tandai keputusan tiap kartu — tersimpan otomatis di peramban ini.

21

△ KOREKSI CLUE LAMA

13

KEYAKINAN SEDANG

7

TEMUAN PPK RESMI

84

SISA M11 (AMAN, DI LUAR SINI)

Cari kasus atau kata kunci...

0/41 diputuskan

[Reset semua](#) [Salin ringkasan keputusan](#)

△ Bagian A — 21 koreksi clue lama (prioritas)

Tiap kartu menampilkan yang game AJARKAN sekarang (kiri) vs koreksi yang diusulkan (kanan). Keputusan Anda: apakah teks game diperbarui?

faringitis_akut Faringitis Akut Bakterial (Streptokokus Grup A)

 Realita FKTP

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Skor Centor tinggi (demam, eksudat tonsil, KGB servikal nyeri, tanpa batuk) → faringitis Streptokokus Grup A. Lini pertama amoxicillin; bila alergi penisilin, ganti makrolida (eritromisin).

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Di Puskesmas, RADT dan kultur usap tenggorok praktis tak tersedia; diagnosis strep bertumpu pada skor Centor/McIsaac semata — rawan over/undertreatment. Skor lebih andal MENYINGKIRKAN strep daripada memastikannya; jangan klaim 'pasti strep', andalkan skor plus konteks.

SUMBER IDSA GAS Pharyngitis Guideline 2025 (skor klinis); PPK Kemenkes (KMK No. 1936/2022); studi validasi McIsaac di Puskesmas (Sari, Maj. Kedokteran Sriwijaya / Sari Pediatri)

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

tb_paru Tuberkulosis Paru

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Batuk >2 minggu + BB turun + keringat malam + kontak TB = terduga TB. Konfirmasi BTA sputum (hasil besok) → mulai OAT KDT program DOTS, TUNTAS 6 bulan. TB paru adalah kompetensi 4A — DITANGANI di Puskesmas, bukan dirujuk. Skrining kontak serumah.

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

BTA sputum NEGATIF tak menyingkirkan TB (sensitivitas mikroskopis hanya ~50-60%; TB BTA-negatif lazim). Pedoman Nasional TB kini menjadikan TCM/GeneXpert pemeriksaan awal utama, bukan mikroskopis — jangan tunda OAT hanya karena BTA negatif.

SUMBER Pedoman Nasional Penanggulangan TBC Kemenkes 2020 & Petunjuk Teknis TCM GeneXpert Kemenkes 2023; WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 3: Diagnosis 2021

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kia_anc_kehamilan_normal ANC — Kehamilan Normal (Trimester 2)

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

ANC normal: minimal 6x kunjungan (Kemenkes 2020) + tablet tambah darah (Fe 60 mg elemental) minimal 90 tablet + asam folat 400 mcg. Edukasi minum Fe malam hari/setelah makan untuk kurangi mual, jangan bersama teh/kopi. Kenali tanda bahaya P4K, JANGAN medikalisasi kehamilan sehat.

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Ambang anemia T2 lebih rendah: <10,5 g/dL (vs <11 di T1/T3), karena volume plasma naik lebih cepat dari massa eritrosit → Hb turun fisiologis, nadir ~minggu 28-34. Jadi Hb 10,5-10,9 di T2 masih normal, bukan anemia. Lanjutkan Fe profilaksis, jangan buru-buru naik ke dosis terapi.

SUMBER WHO Guideline on Haemoglobin Cutoffs to Define Anaemia 2024; Kemenkes Buku Saku Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil 2023

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kia_preeklampsia_berat Preeklampsia Berat

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Preeklampsia BERAT: TD $\geq 160/110$ + proteinuria + gejala berat (nyeri kepala hebat, gangguan visus, nyeri epigastrium, hiperrefleksia/klonus, trombositopenia, SGOT/SGPT naik). WAJIB stabilisasi MgSO₄ (loading + maintenance) & kendalikan TD dengan nifedipin/metildopa lalu RUJUK ke SpOG. JANGAN dipulangkan — risiko eklampsia/HELLP mengancam nyawa ibu & janin (PNPK Preeklampsia Kemenkes/POGI).

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Preeklampsia berat bisa ditegakkan TANPA proteinuria: hipertensi + ≥ 1 tanda berat (trombositopenia, SGOT/SGPT/kreatinin naik, edema paru, nyeri kepala/gangguan visus, nyeri epigastrium). Jangan tunda MgSO₄/rujuk hanya karena protein urin negatif; edema bukan kriteria.

SUMBER ACOG Practice Bulletin 222 (2020); ISSHP 2018; PNPK Preeklampsia POGI/Kemenkes 2016

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

jiwa_insomnia Insomnia (Gangguan Tidur Non-organik)

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Insomnia kronik: lini PERTAMA adalah higiene tidur + terapi perilaku (CBT-I) — jadwal tidur teratur, kurangi layar/kafein malam, hindari tidur siang panjang, tempat tidur hanya untuk tidur. Farmakoterapi (hipnotik) hanya jangka SANGAT pendek & selektif; benzodiazepin dihindari terutama pada lansia. Singkirkan penyebab sekunder (depresi/cemas, nyeri, OSA, hipertiroid) (PPK Jiwa FKTP / pedoman insomnia).

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Higiene tidur sebagai terapi TUNGGAL buktinya lemah — AASM justru merekomendasikan jangan dipakai sendiri. Komponen CBT-I yang efektif: kontrol stimulus (tempat tidur hanya untuk tidur; keluar bila tak bisa tidur) & pembatasan tidur. Membagikan leaflet higiene ≠ mengobati.

SUMBER AASM Clinical Practice Guideline: Behavioral & Psychological Treatments for Chronic Insomnia (J Clin Sleep Med, 2021); ACP Clinical Practice Guideline: Management of Chronic Insomnia in Adults (Ann Intern Med, 2016)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

anemia_defisiensi_bumil Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

WHO & Permenkes No. 88/2014: anemia bumil bila Hb <11 g/dL. Anemia defisiensi besi (mikrositik hipokrom) → tablet tambah darah 60 mg besi elemental + 400 µg asam folat/hari, diminum bersama sumber vitamin C, hindari bersamaan teh/kopi. Cari sumber kehilangan (cacing tambang) dan evaluasi Hb ulang setelah 1 bulan.

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Mikrositik hipokrom tak selalu defisiensi besi — thalassemia trait lazim di Indonesia dan menurunnya. Curigai bila eritrosit normal/tinggi (indeks Mentzer <13), riwayat keluarga, atau tak respons besi 1 bulan; jangan lanjut besi tanpa bukti defisiensi (risiko kelebihan besi).

→

SUMBER Permenkes No. 88/2014; Pedoman Pengendalian Thalassemia Kemenkes; Indeks Mentzer (Indonesian J Clinical Pathology 2016); BJH 2021 (besi oral aman pada beta-thal minor bila defisiensi terbukti).

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

stroke_iskemik Stroke Iskemik Akut

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Stroke = kegawatan "Time is Brain". Kenali FAST (Face-Arm-Speech-Time) dan SELALU cek gula darah (hipoglikemia adalah peniru stroke). Di FKTP: stabilkan jalan napas/pernapasan/sirkulasi, JANGAN turunkan TD agresif (<220/120 mmHg), RUJUK segera ke RS dengan CT-scan dalam window terapi (SKDI 3B, PERDOSSI). Hipertensi tak terkontrol adalah faktor risiko utama.

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

FAST bisa menyesatkan: stroke sirkulasi posterior sering TANPA pelo/kelemahan klasik — tampil sebagai vertigo mendadak, ataksia, atau diplopia dan mudah salah dilabel 'vertigo perifer'. Vertigo akut + tak mampu berdiri + faktor risiko vaskular → curigai stroke, pakai BE-FAST.

→

SUMBER PERDOSSI Guideline Stroke 2011; KMK RI No. HK.01.07/MENKES/394/2019 (PNPK Tata Laksana Stroke); studi BE-FAST vs FAST — sensitivitas 97,8% vs 58,7% (Cureus 2024); prinsip HINTS untuk vertigo sentral vs perifer.

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_dermatitis_kontak Dermatitis Kontak Alergi

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Dermatitis kontak alergi: lesi terbatas pada AREA KONTAK, membaik saat kontakkan dihindari. Terapi utama = IDENTIFIKASI & HINDARI ALERGEN (mis. sarung tangan saat mencuci) + kortikosteroid topikal potensi ringan-sedang (hidrokortison) + antihistamin untuk gatal (PPK Perdoski).

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Dermatitis kontak ALERGI dan IRITAN tampak identik secara klinis; pada ibu rumah tangga dengan tangan terus basah (air, sabun, detergen), penyebab tersering justru IRITAN, bukan alergi. Keduanya tak bisa dipisahkan pasti tanpa uji tempel — jangan terpaku pada label 'alergi'.

SUMBER PPK PERDOSKI 2021 (Dermatitis Kontak Iritan & Alergi); Panduan Praktik Klinis Dokter FKTP (Permenkes 5/2014)

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_pioderma_impetigo Pioderma — Impetigo Krustosa

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Impetigo krustosa: KRUSTA MADU (honey-colored) di wajah anak. Terlokalisir → LINI PERTAMA mupirosin topikal (IDSA/Perdoski); LUAS/multipel → tambah antibiotik oral anti-Staph (cefadroxil; eritromisin bila alergi penisilin). Rendam & lepaskan krusta, potong kuku, cuci tangan (PPK Perdoski/IDAI).

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Mengobati impetigo TIDAK terbukti mencegah glomerulonefritis pascastreptokokus (GNAPS) — beda dari demam rematik. Jangan janjikan antibiotik 'mencegah komplikasi ginjal'; ia diberi untuk mempercepat sembuh & memutus penularan. Tetap pantau tanda GNAPS (bengkak, urin merah).

SUMBER CDC Clinical Guidance for Group A Streptococcal Impetigo 2024; AAFP "Poststreptococcal Illness" 2018; IDSA SSTI 2014; Cochrane "Interventions for impetigo" 2012

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_herpes_zoster Herpes Zoster

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Herpes zoster: vesikel bergerombol UNILATERAL dermatomal + nyeri neuralgik. ASIKLOVIR HARUS dimulai <72 JAM sejak ruam (asiklovir 5×800 mg/hari 7 hari;

→

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Batas 72 jam bukan tenggat mutlak: asiklovir tetap bermanfaat >72 jam bila masih ada vesikel BARU, atau pada imunokompromais/DM, zoster oftalmikus,

sediaan 400 mg → 2 tablet per dosis) untuk memangkas durasi & risiko NEURALGIA PASCAHERPETIK. Analgesik adekuat. Waspada zoster oftalmikus (rujuk mata) (PPK Perdoski/CDC).

dan lansia. Jangan tolak antivirus hanya karena pasien datang hari ke-4 — DM + usia lanjut tetap indikasi terapi.

SUMBER CDC Shingles Clinical Overview (HCP) 2024; PPK PERDOSKI Herpes Zoster; CDK Journal 2023 (Herpes Zoster pada Lansia DM)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_pedikulosis_kapitis Pedikulosis Kapitis (Kutu Kepala)

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Pedikulosis kapitis: gatal kulit kepala + NITS melekat erat di batang rambut (beda dari ketombe). Permetrin krim (di Puskesmas tersedia sediaan 5%; standar ideal pedikulisida 1%) dioleskan merata ke rambut & kulit kepala, DIAMKAN 10 menit lalu bilas, ULANGI 7-10 hari (bunuh nimfa yang menetas). WAJIB: obati SEMUA KONTAK (serumah/sekelas) SERENTAK + sisir serit + rendam sisir/cuci topi-seprai-bantal air PANAS ($\geq 60^{\circ}\text{C}$) (PPK Perdoski/CDC).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Nits yang menempel BUKAN bukti infestasi AKTIF — cangkang telur kosong bisa bertahan berbulan-bulan; diagnosis aktif butuh menemukan KUTU/nimfa HIDUP. Gagal terapi permetrin sering karena RESISTENSI piretroid, bukan semata reinfestasi kontak — pertimbangkan ganti agen.

SUMBER CDC Head Lice (Diagnosis & Clinical Care) 2024; AAP Clinical Report "Head Lice" 2022 (Pediatrics 150(4):e2022059282)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

mm_osteoarthritis_lutut Osteoarthritis Lutut

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Osteoarthritis lutut: nyeri MEKANIK (memberat aktivitas, mereda istirahat) + kaku pagi SINGKAT (<30 menit) + krepitasi + usia lanjut, TANPA tanda inflamasi sistemik. Tata laksana: edukasi + latihan penguatan kuadrisep + turun BB + analgetik (parasetamol dulu, NSAID bila perlu; hati-hati lambung/ginjal/TD). Rontgen bukan syarat diagnosis (klinis cukup). Rujuk hanya bila kandidat operasi/sendi gagal (PPK / OARSIS).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Jebakan: parasetamol nyaris tak bermanfaat pada OA lutut (Lancet 2016); pedoman internasional (NICE/OARSIS) utamakan OAINS TOPIKAL lini pertama. Tapi topikal tetap OAINS — pada pasien alergi NSAID ini justru kontraindikasi, jadi parasetamol + latihan tetap pilihan tepat.

→

SUMBER da Costa et al., The Lancet 2016 (NMA OA, 58.556 pasien); NICE NG226 (2022); OARSIS 2019; Rekomendasi Diagnosis & Penatalaksanaan OA IRA/PB IRA 2014; label diklofenak gel FDA (kontraindikasi hipersensitivitas NSAID)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

mm_low_back_pain Low Back Pain Mekanik (Nyeri Punggung Bawah)

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Low back pain mekanik tanpa RED FLAG (tanpa defisit neurologis, tanpa gangguan BAK/BAB, tanpa demam/BB turun/riwayat kanker/trauma berat) → tata laksana KONSERVATIF: edukasi + analgetik (parasetamol/NSAID) + TETAP AKTIF (hindari tirah baring total) + koreksi ergonomi. JANGAN rontgen/rujuk rutin — pencitraan hanya bila ada red flag (PPK Nyeri Punggung Bawah / NICE LBP).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Parasetamol tunggal TIDAK lebih unggul dari plasebo pada LBP akut (PACE, Lancet 2014); OAINS oral jadi lini pertama bila tak ada kontraindikasi lambung/ginjal/kardiovaskular. Parasetamol bukan monoterapi andalan, tapi berguna sebagai kombinasi atau saat OAINS kontraindikasi.

→

SUMBER Williams et al., Lancet 2014 (PACE trial); NICE NG59 Low Back Pain & Sciatica (2016, rev. 2020); PPK Neurologi PERDOSSI 2016

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

mm_isk_bawah Infeksi Saluran Kemih Bawah (Sistitis)

Realita FKTP

SEDANG

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

ISK bawah / sistitis akut tanpa komplikasi (perempuan, disuria + frekuensi + urgensi, TANPA demam tinggi/nyeri pinggang/CVA negatif) → antibiotik lini pertama (kotrimoksazol) 3 hari + banyak minum + jangan menahan kencing. WAJIB singkirkan kehamilan (ubah pilihan antibiotik) & pielonefritis (demam tinggi + nyeri ketok CVA = infeksi atas, alur berbeda). Cadangkan fluorokuinolon (PPK ISK / IDSA).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Kotrimoksazol lini pertama mengandaikan resistensi lokal <20%, padahal resistensi E. coli di Indonesia umumnya >20% (AMRIN ~29–56%). Nitrofurantoin/fosfomisin lebih ideal tapi sering kosong di Puskesmas — jadi kotrimoksazol, bahkan siprofloksasin, kerap tetap dipakai.

→

SUMBER IDSA/ESCMID 2011 (Gupta et al., Clin Infect Dis 52:e103); AMRIN Study (Kemenkes, E. coli resisten kotrimoksazol 29% komunitas / 56% RS); Fornas (kesesuaian obat FKTP ~50–62%)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

rinitis_alergi Rinitis Alergi

Realita FKTP

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Rinitis alergi: bersin serial + rinorea ENCIER JERNIH + gatal hidung/mata, dipicu debu/pagi, TANPA demam, riwayat atopi keluarga. Terapi lini pertama antihistamin non-sedatif (loratadin/setirizin) + kontrol lingkungan (ARIA/PPK IDI). Bedakan dari common cold (durasi lebih lama, gatal menonjol, tanpa demam).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

ARIA jadikan kortikosteroid intranasal (flutikason) lini utama rinitis persisten sedang-berat, tapi steroid semprot ini kerap tak tersedia di Puskesmas. Praktik nyata pakai antihistamin oral—sering CTM gen-1 yang murah tapi bikin kantuk, bukan loratadin/setirizin.

→

SUMBER ARIA next-generation (GRADE) 2019, JACI; PPK Dokter FKTP (KMK 514/2015); Fornas (klorfeniramin/loratadin/setirizin terdaftar)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

disentri_basiler Disentri Basiler (Shigellosis)

Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Disentri BASILER (Shigella): diare sedikit-sedikit tapi sering, DARAH + lendir, demam, tenesmus, leukosit feses banyak. Beri antibiotik (siprofloksasin) + rehidrasi oralit; JANGAN beri antimotilitas (loperamid). Zinc = terapi baku hanya untuk anak <5 tahun (bukan dewasa). Bedakan disentri AMEBA (trofozoit di feses) → metronidazol. Kontras dengan diare akut cair non-disentri yang TANPA antibiotik (Kemenkes; WHO).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Satu kali mikroskopi feses negatif TIDAK menyingkirkan amubiasis — sensitivitas 1 sampel hanya ~33-50% (perlu feses segar-hangat & periksa serial). Bila tak membaik dengan siprofloksasin, pertimbangkan ameba/metronidazol; jangan sandarkan diagnosis pada satu hasil negatif.

→

SUMBER WHO — tata laksana disentri/amubiasis (mikroskopi feses tunggal sensitivitas rendah; uji spesifik E. histolytica); Medscape/AMBOSS Amebiasis Workup 2023-24; PPK IDI 2017 (Disentri); LINTAS DIARE Kemenkes

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

saraf_bells_palsy

Bell's Palsy (Parese Nervus Fasialis Perifer)

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Bell's palsy = parese N.VII PERIFER akut: DAHI IKUT LUMPUH (bedakan dari stroke/sentral yang dahinya terhindar karena persarafan bilateral). Kortikosteroid dini (prednison, mulai <72 jam) memperbaiki prognosis. WAJIB proteksi kornea: air mata buatan + tutup mata saat tidur karena mata tak bisa menutup. Skrining vesikel (Ramsay Hunt) & tanda sentral (PPK PERDOSSI/AAN).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Absennya vesikel pada kunjungan pertama BELUM menyingkirkan Ramsay Hunt — vesikel bisa muncul beberapa hari SETELAH kelumpuhan (bahkan zoster sine herpete, tanpa ruam). Wajah lumpuh bilateral atau progresif >2 minggu juga bukan Bell's khas: cari penyebab lain.

→

SUMBER AAFP Bell Palsy Rapid Evidence Review 2023; AAN Practice Guideline (Gronseth 2012); DermNet NZ / Medscape Ramsay Hunt Syndrome; PPK PERDOSSI Bell's Palsy.

► [Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

saraf_epilepsi_kejang

Epilepsi (Bangkitan Umum Tonik-Klonik Berulang)

📺 Realita FKTP

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Bangkitan tak beralasan BERULANG (≥ 2 kali, jeda > 24 jam, tanpa demam/pencetus akut) memenuhi definisi epilepsi → butuh EEG + pemilihan OAE jangka panjang oleh SPESIALIS SARAF. Peran FKTP: sediakan rescue bangkitan yang benar (diazepam REKTAL 10 mg, BUKAN tablet oral), pertolongan pertama aman, edukasi keluarga, lalu RUJUK. Jangan mulai OAE rumatan sendiri tanpa klasifikasi (PPK PERDOSSI).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Idealnya EEG + OAE oleh neurolog, tapi di banyak daerah keduanya tak terjangkau; WHO mhGAP membenarkan GP terlatih memulai OAE lini-1 (fenobarbital/valproat untuk bangkitan umum) sambil merujuk. Diazepam rektal untuk rescue sering kosong stok di Puskesmas.

→

SUMBER WHO mhGAP-IG Epilepsy 2016; PPK PERDOSSI Epilepsi; Fornas (diazepam rektal 5 mg, OAE fenobarbital/valproat/fenitoin tingkat FKTP)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

tht_epistaksis_anterior Epistaksis Anterior

💡 Mutiara EBM

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Epistaksis anterior (pleksus Kiesselbach): pertolongan pertama = duduk MENUNDUK ke depan + tekan cuping hidung (pinch) 10-15 menit + kompres dingin. Dekongestan topikal (oksimetazolin) sebagai vasokonstriktor; bila belum berhenti pasang TAMPON ANTERIOR. Kendalikan faktor pencetus: TEKanan DARAH tinggi WAJIB diobati (kepatuhan obat HT). Rujuk bila epistaksis posterior/masif/berulang tak terkendali (PPK PERHATI-KL).

KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

TD tinggi saat mimisan sering reaktif thd nyeri/cemas & turun sendiri sesudah perdarahan berhenti; kausalitas HT-epistaksis lemah (asosiasi saja). Prioritas: tekan cuping 10-15 mnt + tenangkan lalu ukur ulang TD, bukan kejar penurunan TD akut. Kontrol HT jangka panjang tetap penting.

→

SUMBER AAO-HNS CPG Nosebleed (Epistaxis) 2020 (Tunkel dkk.); Payne dkk. 2020, Otolaryngol Head Neck Surg; Jurnal Kesehatan Andalas — Epistaksis dan Hipertensi

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

tht_epistaksis_anterior Epistaksis Anterior

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Epistaksis anterior (pleksus Kiesselbach):
pertolongan pertama = duduk **MENUNDUK**
ke depan + tekan cuping hidung (pinch) 10-
15 menit + kompres dingin. Dekongestan
topikal (oksimetazolin) sebagai
vasokonstriktor; bila belum berhenti pasang
TAMPON ANTERIOR. Kendalikan faktor
pencetus: **TEKANAN DARAH** tinggi **WAJIB**
diobati (kepatuhan obat HT). Rujuk bila
epistaksis posterior/masif/berulang tak
terkendali (PPK **PERHATI-KL**).



KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Merocel & kauter perak-nitrat jarang ada di
Puskesmas; realistiknya epistaksis anterior:
tekan cuping 10-15 mnt, lalu tampon
kasa+vaselin ± kapas **ADRENALIN** (epinefrin
1:10.000, andalan Fornas; oksimetazolin
spray tak selalu distok). Bila tak berhenti,
rujuk **THT**.

SUMBER Alomedika/KalbeMed Epistaksis 2023-2024 (Merocel/rapid rhino tak tersedia di semua fasilitas; kapas adrenalin 1:10.000 rutin); Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023) & E-Katalog LKPP (oksimetazolin 0,025%); Permenkes 75/2014 standar peralatan Puskesmas; PPK **PERHATI-KL** Epistaksis.

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

tht_rinosinusitis_akut Rinosinusitis Akut

YANG GAME AJARKAN SEKARANG (CLUE)

Rinosinusitis akut **MAYORITAS VIRAL** & self-
limiting. Curiga **BAKTERIAL** bila: gejala > 10
hari tanpa perbaikan, ATAU "double
sickening" (membaik lalu memburuk), ATAU
berat (demam ≥ 39 , nyeri wajah/ingus
purulen berat) — baru beri antibiotik
(amoksisilin ± klavulanat). Dekongestan +
analgetik + bilas salin sebagai penunjang.
Waspada red flag komplikasi
orbita/intrakranial → rujuk (**EPOS/PPK**
PERHATI-KL).



KOREKSI/TAMBAHAN YANG DIUSULKAN

Di FKTP antibiotik sering diberikan sejak hari
ke-1/2 untuk pilek biasa (over-prescribing).
Di Fornas, amoksisilin-klavulanat direstriksi
(lanjutan parenteral/uji resistensi), sehingga
pilihan realistis adalah amoksisilin dosis
adekuat — hanya bila kriteria bakterial
terpenuhi.

SUMBER Fornas 2023 (KMK HK.01.07/MENKES/2197/2023); EPOS 2020; studi rasionalitas antibiotik ISPA Puskesmas Indonesia (program POR Kemenkes)

► Kenapa verifikator bilang ini mengoreksi clue

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

Bagian B — 13 keyakinan sedang

Faktual & bersitasi, tapi verifikator menandai perlu pertimbangan Anda (bukti lebih lemah, konteks lokal, atau nuansa penerapan).

demam_tifoid Demam Tifoid

 Realita FKTP

SEDANG

Kultur darah (baku emas) praktis tak ada di Puskesmas. WHO/global geser ke seftriakson/azitromisin/fluorokuinolon akibat resistensi, tapi *S. typhi* Indonesia umumnya masih sensitif kloramfenikol — Fornas jadikan lini-1: murah, efektif. Wajib tuntas + pantau hematologik.

SUMBER WHO Typhoid treatment (azithromycin/ceftriaxone/ciprofloxacin); PPK Demam Tifoid IDAI/PAPDI (kloramfenikol lini-1, sefiksिम/seftriakson lini-2 MDR); Fornas FKTP; data resistensi *S. typhi* Asia (Bangladesh 1999–2022, medRxiv 2023)

► Catatan verifikator (kenapa cuma keyakinan sedang)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

konjungtivitis_bakterial Konjungtivitis Bakterial

 Realita FKTP

SEDANG

Tetes mata steroid/steroid-antibiotik (mis. deksametason, Cendo Xitrol) sebenarnya obat KERAS wajib resep, tapi lazim ditebus tanpa resep di apotek — pasien swamedikasi steroid pada mata merah, berisiko memperberat keratitis herpes/glaukoma hingga ulkus kornea.

SUMBER AAO Preferred Practice Pattern — Conjunctivitis (2018); Penjelasan BPOM RI — deksametason & tetes mata steroid = golongan Obat Keras wajib resep (2020)

► Catatan verifikator (kenapa cuma keyakinan sedang)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kia_abortus_iminens Abortus Iminens (Ancaman Keguguran)

 Realita FKTP

SEDANG

Realita: abortus iminens rutin diberi progestin oral (alilestrenol/didrogesteron) walau bukti manfaat terbatas—progesteron vaginal (PRISM) hanya menolong subgrup dengan riwayat keguguran; pada pasien tanpa riwayat belum terbukti & bukan keharusan. Inti: rujuk USG.

SUMBER PRISM RCT (Coomarasamy dkk., NEJM 2019); NICE NG126 (2019, upd. 2025); meta-analisis progestogen (Zhao dkk., Acta Obstet Gynecol Scand 2024); praktik lapangan RI (Premaston/Duphaston, obat keras rutin diresepkan)

► Catatan verifikator (kenapa cuma keyakinan sedang)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

jiwa_depresi_ringan Episode Depresif Ringan

 Realita FKTP

SEDANG

Idealnya (mhGAP/NICE NG222) depresi ringan: psikoedukasi + aktivasi perilaku + active monitoring dulu, antidepresan tak rutin. Realita FKTP: layanan psikologi sering tak ada (hanya ~40% Puskesmas punya layanan jiwa) & kontrol sulit, obat kerap langsung diberi — bila perlu, disertai rencana kontrol + skrining bunuh diri.

SUMBER NICE NG222 (2022); WHO mhGAP-IG v2.0 & Update 2023; Kemenkes/PDSKJI — cakupan layanan jiwa Puskesmas ~40% & mandat psikolog klinis PMK No.19/2024

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kia_malaria_falsiparum Malaria Falsiparum

 Realita FKTP

SEDANG

Malaria impor: pasien pulang dari Papua/NTT kerap berobat di Puskesmas Jawa/Bali non-endemis yang tak menstok RDT & ACT (DHP)/primakuin (distribusi terfokus daerah endemis) → diagnosis terlambat. Curigai demam+riwayat perjalanan; siapkan rujukan & lapor e-SISMAL.

SUMBER Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria Kemenkes 2023; KMK No.556/2019 (PNPK Malaria); e-SISMAL Kemenkes; laporan kasus malaria impor wilayah non-endemis (Medicina Udayana, 2024)

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

otitis_media_akut Otitis Media Akut

 Realita FKTP

SEDANG

Dosis tinggi amoksisilin 80–90 mg/kg/hari (AAP 2013) di lapangan sering menyusut jadi ~40–50 mg/kg/hari — memadai untuk pneumokokus peka, tapi bisa gagal pada strain resisten. Otoskop berfungsi pun tak selalu ada, sehingga 'bulging' tak ternilai dan diagnosis jadi terkaan.

SUMBER AAP AOM Guideline 2013 (Lieberthal, Pediatrics); "Optimizing antibiotic use in Indonesia" systematic review 2022; Permenkes 43/2019 (peralatan Puskesmas)

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_pioderma_impetigo **Pioderma — Impetigo Krustosa**

 Realita FKTP

SEDANG

Mupirosin (lini pertama pedoman) sering TIDAK distok di Puskesmas—umumnya sediaan bermerek. Realistik: salep gentamisin generik (paling sering ada), asam fusidat, atau langsung antibiotik oral anti-Staph (sefadroksil). Sesuaikan stok Fornas/e-katalog setempat; jangan resepkan obat yang kosong.

SUMBER Fornas — KMK No. HK.01.07/Menkes/2197/2023 (berlaku Mar 2024); IDSA SSTI Guidelines 2014 & PPK Perdoski (mupirosin lini pertama impetigo); praktik FKTP Indonesia (diskusi klinis Alomedika)

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_herpes_zoster **Herpes Zoster**

 Realita FKTP

SEDANG

Asiklovir zoster 5×800 mg/hari (di FKTP = 5×2 tab 400 mg = 10 tablet/hari, 7 hari) menekan kepatuhan. Valasiklovir 3×1 g lebih ringkas dan ADA di Fornas, tapi restriksi tingkat RS & lebih mahal—tak lazim di Puskesmas. Realistik tetap asiklovir 5×/hari; kunci: alarm & jadwal minum.

SUMBER PPK Perdoski (dosis asiklovir 5×800 mg & valasiklovir 3×1 g herpes zoster); Fornas 2023 (KMK Menkes No. HK.01.07/2197/2023, kelas 6.6.1 Antiherpes — asiklovir tab 200/400 mg tersedia TK-1/FKTP, valasiklovir 500 mg restriksi tingkat lanjut)

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_varisela **Varisela (Cacar Air)**

 Realita FKTP

SEDANG

VZIG untuk kontak rentan berisiko (mis. bumil) idealnya ≤96 jam (bisa s/d 10 hari) pascapajanan, tetapi praktis tak tersedia di Indonesia. Realistik: rujuk bumil ke SpOG; bila VZIG tak ada, asiklovir oral profilaksis mulai hari ke-7-10 dapat dipertimbangkan.

SUMBER CDC MMWR 2013 (Updated Recommendations for Use of VariZIG — hingga 10 hari); AAP Red Book & VZV post-exposure prophylaxis review (PMC6931226, 2019)

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_kandidiasis_kutis **Kandidiasis Kutis (Intertriginosa)**

 Realita FKTP

SEDANG

Lampu Wood pemisah eritrasma-kandida sering tak ada di Puskesmas dan KOH jarang dikerjakan rutin, jadi terapi kerap empiris. 'Jaga area kering' sulit pada pasien obes di iklim lembap — rekurensi tinggi selama BB, kelembapan, dan gula darah belum dikoreksi.

SUMBER PPK PERDOSKI 2021 (kandidiasis kutis); Fornas 2023 (Kepmenkes HK.01.07/MENKES/2197/2023 — mikonazol/ketokonazol/nistatin topikal); StatPearls Erythrasma 2023 (fluoresensi coral-red lampu Wood)

► Catatan verifikator (kenapa cuma keyakinan sedang)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

mm_dislipidemia Dislipidemia

💡 Mutiara EBM

SEDANG

LDL $\geq$ 190 mg/dL yang terisolasi + riwayat jantung dini keluarga bukan sekadar 'kolesterol gaya hidup' — curigai Hiperkolesterolemia Familial & rujuk untuk skrining keluarga. Di kasus ini pola campuran (TG tinggi, HDL rendah, obesitas) condong ke dislipidemia metabolik.

SUMBER PB PERKENI, Panduan Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia 2021; kriteria Dutch Lipid Clinic Network (DLCN); ESC/EAS Dyslipidaemias 2019

► Catatan verifikator (kenapa cuma keyakinan sedang)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

mm_dislipidemia Dislipidemia

🏠 Realita FKTP

SEDANG

Di praktik FKTP, statin yang tersedia lazimnya hanya simvastatin (intensitas sedang); atorvastatin/rosuvastatin intensitas tinggi jarang ada di rak Puskesmas. Pemantauan ulang lipid & SGOT/SGPT sering terlewat, dan pasien kerap putus obat karena merasa 'tak ada keluhan'.

SUMBER PERKENI Panduan Pengelolaan Dislipidemia 2021; Fornas (KMK Kemenkes terbaru); Pedoman PTM Kemenkes

► Catatan verifikator (kenapa cuma keyakinan sedang)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

hemoroid_grade1 Hemoroid Interna Grade 1

🏠 Realita FKTP

SEDANG

Kolonoskopi untuk menyingkirkan keganasan hanya di RS rujukan; anoskopi kerap tak dipakai dan tes darah samar tinja (FOBT) baru digulirkan lewat program skrining, belum merata— sehingga banyak perdarahan rektal 'diamati saja' karena rujukan terkendala antrean, jarak, dan biaya.

SUMBER Permenkes 43/2019 (standar Puskesmas); Kemenkes — Skrining Kanker Kolorektal via Cek Kesehatan Gratis 2025 (RAN Penanggulangan Kanker 2024–2034); PPK IDI Hemoroid

► [Catatan verifikator \(kenapa cuma keyakinan sedang\)](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

Bagian C — 7 temuan cross-check PPK Kemenkes 1186/2022

Dari cross-check 72 kasus vs Panduan Praktik Klinis resmi FKTP (workflow 2026-07-10, 59 ditemukan di PPK). Sudah ditriase turun dari 72 mentah -- yang lolos di sini murni benturan EBM/dosis/kode NYATA, bukan kasus PRIMERA sekadar lebih spesifik dari kode umum PPK (aman) atau salah-pasang entri oleh workflow saya sendiri (sudah dibuang).

`mata_konjungtivitis_alergi` Konjungtivitis Alergi

 PPK Kemenkes

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Game saat ini: antihistamin oral (loratadin) + air mata buatan, EKSPISIT melarang steroid ("risiko glaukoma/katarak").

→

MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022 (hlm 210):
merekendasikan tetes mata Flumetolon (STEROID topikal) 2x/hari selama 2 minggu sbg lini pertama di FKTP.

SUMBER Kepmenkes HK.01.07/MENKES/1186/2022, hlm 210

► [Catatan](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

`otitis_media_akut` Otitis Media Akut

 PPK Kemenkes

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Clue game: amoksisilin dosis TINGGI 80-90mg/kgBB/hari (pedoman AAP internasional, utk area resistensi pneumokokus tinggi).

→

MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022 Tabel 5.2: amoksisilin dosis STANDAR 25-50mg/kgBB/hari.

SUMBER Kepmenkes 1186/2022, Tabel 5.2

► [Catatan](#)

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

anemia_defisiensi_bumil Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan

 PPK Kemenkes

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Clue game: asam folat 400 mcg/hari.



MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022 (Tabel 14.7, hlm 724): tablet tambah darah standar = 60mg besi elemental + 250mcg asam folat PER TABLET, diberikan 3x/hari pada bumil dgn anemia (~750mcg folat/hari total).

SUMBER Kepmenkes 1186/2022, Tabel 14.7 & hlm 724

► Catatan

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

kulit_pedikulosis_kapitis Pedikulosis Kapitis (Kutu Kepala)

 PPK Kemenkes

TINGGI

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Clue game: permetrin DIAMKAN 10 menit lalu bilas, ULANGI 7-10 hari; WAJIB obati SEMUA kontak serumah SERENTAK.



MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022: permetrin 1% DIBIARKAN 2 JAM sebelum dibilas (tak dianjurkan usia <2 th); kontak serumah DIPERIKSA tapi HANYA yang terbukti infestasi yang diobati (bukan blanket-treat semua kontak).

SUMBER Kepmenkes 1186/2022 (Pedikulosis Kapitis, ICD B85.0)

► Catatan

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

demam_tifoid Demam Tifoid

 PPK Kemenkes

SEDANG

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Clue game menyebut sefiksim/seftriakson seolah opsi setara



MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022 memisahkan tegas: lini PERTAMA = kloramfenikol/ampisilin-amoksisilin/kotrimoksazol; lini KEDUA =

kloramfenikol/kotrimoksazol/amoksisilin
(‘bila tersedia & sesuai antibiogram/derajat’).

seftriakson/sefiksim/kuinolon, HANYA bila
ini pertama terbukti gagal.

SUMBER Kepmenkes 1186/2022 (Demam Tifoid, ICD A01.0)

► Catatan

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

hemoroid_grade1 Hemoroid Interna Grade 1

PPK Kemenkes

SEDANG

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Game pakai ICD-10 K64.0 (gaya ICD-10-
CM/Amerika).

→

MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022 pakai ICD-10 I84 (bab
sirkulasi, WHO ICD-10 standar internasional).

SUMBER Kepmenkes 1186/2022 (Hemoroid Grade 1-2, hlm 161-164)

► Catatan

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

apendisitis_akut Apendisitis Akut

PPK Kemenkes

SEDANG

YANG GAME AJARKAN SEKARANG

Game pakai ICD-10 K35.8 (sudah diverifikasi
WHO-valid di audit Q8 sebelumnya).

→

MENURUT PPK KEMENKES 1186/2022

PPK 1186/2022 mencantumkan 'K.35.9'
(unspecified) utk entri yang sama.

SUMBER Kepmenkes 1186/2022 (Apendisitis Akut, hlm 173-177)

► Catatan

KEPUTUSAN: ☐ Setuju ☐ Perlu edit ☐ Tolak ☐ Nanti

Dari riset `m11-pengayaan-riset` (2026-07-10). 84 kandidat keyakinan-tinggi & tambahan-murni tak ditampilkan di sini (aman di batch-approve; ada di dossier lengkap `M11_CODEX_TERPADU`). Keputusan tersimpan di localStorage peramban ini saja — tak terkirim ke mana pun.